

Lado de trabajo y lado de balance

1. El movimiento de lateralidad

Definición

Es el desplazamiento de la mandíbula hacia un lado. Es un movimiento **asimétrico**: los dos cóndilos hacen cosas distintas al mismo tiempo. Entender esa asimetría es la clave de todo el tema.

Los dos lados

- **Lado de trabajo**: aquel **hacia donde** se desplaza la mandíbula. También se le llama lado activo o de rotación.
- **Lado de balance o de no trabajo**: el lado **contrario** al movimiento. También se le llama lado de orbitación o lado inactivo.

Regla práctica: si la mandíbula va hacia la derecha, el lado **derecho** es de trabajo y el **izquierdo** es de balance.

2. Qué hace cada cóndilo

Cóndilo de trabajo (rotante)

Permanece prácticamente en su sitio y **rota** sobre su eje vertical. Al mismo tiempo puede efectuar un pequeño desplazamiento lateral hacia afuera conocido como **movimiento de Bennett** (desplazamiento lateral inmediato o progresivo, según el caso).

Cóndilo de balance (orbitante)

Se desplaza **hacia abajo, adelante y hacia adentro**, recorriendo la vertiente posterior de la eminencia articular. El **ángulo de Bennett** describe la desviación hacia medial de esa trayectoria respecto al plano sagital.

Consecuencia clínica de la asimetría

Como el cóndilo de balance **desciende**, del lado de balance se genera un **espacio** entre las arcadas. Por eso, en condiciones normales, **los dientes de ese lado no deben tocarse**.

3. Qué debe ocurrir en cada lado

En el lado de trabajo

El contacto es **esperado y funcional**, y puede darse de dos formas:

- **Función canina**: solo el canino mantiene contacto y desocluye a todos los posteriores.
- **Función de grupo**: el contacto se reparte entre canino, premolares y en ocasiones la cúspide mesiovestibular del primer molar.

El contacto normal ocurre entre las **vertientes internas de las cúspides vestibulares superiores** y las **vertientes externas de las cúspides vestibulares inferiores**.

En el lado de balance

No debe haber ningún contacto. Cualquier toque en este lado se considera interferencia, sin excepción. Es el criterio más rotundo del análisis oclusal.

4. Interferencias del lado de trabajo

Dónde se localizan

Habitualmente entre vertientes internas de cúspides vestibulares superiores y vertientes externas de cúspides vestibulares inferiores, en premolares y molares.

Por qué son interferencia si el contacto es esperado

Porque lo que se busca es una **desoclusión progresiva y armónica** de los posteriores. Cuando un diente posterior sostiene el contacto e **impide que los demás desocluyan**, deja de ser función y se convierte en obstáculo.

Efectos

Sobrecarga localizada, facetas de desgaste en las vertientes implicadas, movilidad del diente afectado y fatiga muscular del mismo lado.

5. Interferencias del lado de balance

Por qué son las más lesivas

Concurren tres factores:

- Se producen **cerca del fulcro articular**, donde el sistema actúa como palanca y multiplica la fuerza sobre el diente que contacta.
- Ocurren con los **músculos elevadores en plena contracción**.
- El paciente **no las percibe**, porque están fuera de su patrón consciente de masticación.

Dónde aparecen con más frecuencia

En la zona más posterior: segundos y terceros molares. Un tercer molar mal posicionado es sospechoso habitual, precisamente por su cercanía a la articulación.

Efectos

Dolor y sobrecarga articular del lado contrario al contacto, dolor muscular, fracturas cuspidéas y movilidad del diente implicado. Se asocia con sintomatología de ATM.

6. Cómo analizarlas en clínica

Procedimiento

1. Secar las superficies oclusales.
2. Marcar primero la **céntrica** con papel articular de un color.
3. Cambiar al **segundo color** y pedir movimientos de lateralidad derecha e izquierda.
4. Repetir en protrusión.
5. Registrar en el odontograma qué diente y qué vertiente marcó, y en qué movimiento.

Interpretación de las marcas

Una marca en el lado de trabajo puede ser función; una marca en el lado de balance **siempre** es interferencia. De ahí la importancia de usar dos colores: sin ellos no se distingue qué contacto corresponde a qué movimiento.

Limitación de la exploración en boca

La propiocepción periodontal hace que el paciente **evite instintivamente** el contacto molesto, así que puede no reproducir el movimiento completo. Por eso el análisis se complementa con **modelos montados en articulador semiajustable**, que carecen de ese reflejo.

7. Análisis en el articulador

Qué se requiere

Modelos montados con **arco facial** y **registro en relación céntrica**. Sin esos dos elementos, el análisis de movimientos excéntricos no es válido.

Qué se observa

Al simular la lateralidad se identifica con claridad si algún diente del lado de balance mantiene contacto, y si la desoclusión del lado de trabajo es progresiva o queda retenida por un solo diente.

Valor didáctico

Es el ejercicio que permite **ver** lo que en boca solo se intuye. Comparar lo marcado en el paciente con lo observado en el articulador es la mejor forma de educar el criterio.

Material de apoyo para la asignatura de Oclusión. Complementar con la bibliografía indicada por el catedrático.